DNARは原因を問わず範囲を明示して運用する — 原疾患限定論の限界とinformed nondissent・TLT

「DNARの患者が予期せず心停止したら蘇生するか」という問いをめぐる臨床医の論考を出発点に、論点を一次資料（日本集中治療医学会の勧告と委員会報告、4学会合同ガイドライン2026、AHA 2025 蘇生ガイドライン倫理編、フレイルとCPR転帰の研究）で確かめながら整理した要約。原文の引き写しではない。最終更新 2026-10-19

DNAR　コードステータス　SDM　informed nondissent　TLT　フレイル



心停止は夜の病棟で、最初に看護師が見つけることが多い。そのとき迷わずにすむ指示を、事前の話し合いで作っておく。

§0 3行まとめ

心停止の原因で線を引く議論をやめ、DNARの範囲を事前の話し合いで明確にしておく。これがこの資料の結論です。ただし範囲を決めるのは入院の入口ではありません。入口では本人の推定意思を聴き、経過の中で本人の価値観と治療目標から蘇生方針を合意し、DNARとするなら範囲を明示します（§5）。

3行まとめ

1. **フレイルからみてCPRが無益だという見込みは、DNARを考える医学的な「材料」であって「結論」ではない。決め手は本人にとってのゴールにある。**
2. **DNARは「心停止時は原因を問わずCPRを行わない」と範囲を明示して指示する。看護師にその場で原因を判断させない。処置に伴う医原性の心停止だけは、事前に例外として扱いを決めておく。**
3. **単一の指標で線を引かず、医療・ケアチームの臨床倫理的検討と本人・家族等とのSDMで、必要ならTLTで確かめながら見直し続ける（4学会合同ガイドライン2026の構造）。**

§1 題材の症例 — 話し合ったのに意見が割れる

家族と話し合ってDNARになっていたのに、医療者の意見は割れました。足りなかったのは話し合いの有無ではなく、合意の解像度です。



肺炎は改善傾向。夜間の訪室で心停止が見つかったら、蘇生するか。

症例

90歳、要介護4。誤嚥性肺炎で入院7日目。家族と話し合ってDNARになっている。肺炎は改善傾向だったが、訪室すると心停止していた。蘇生するか。

- SNS上のアンケート（3万票超）では「蘇生すべきでない」76%、「すべき」20%。前日に命題として「DNARは原疾患による心停止だけに適用されるか」と聞いたときは「正しい」が34%だった。症例に「90歳・要介護4」が入ると、原因ではなく患者背景で答える人が増えた。
- 意見は5つに分かれた：蘇生すべき（原疾患限定の解釈・訴訟対策）、蘇生すべきでない（最多）、入院時のICで範囲を決めておけ、形だけ蘇生する（スローコード）、制度とガイドラインへの批判。

！論点の核心

「蘇生しない」が原疾患に限るのか、原因を問わないのか。**合意の中身が詰まっていなかった**から意見が割れた。問題は話し合ったかどうかではなく、合意の解像度にある。

§2 DNARの土台 — 一次資料で確かめる

DNARは心停止時だけに効く指示で、通常の治療を控える理由にはなりません。原疾患に限るという定めは、学会の文書には見当たりません。

表1｜DNARの土台

論点	内容	出典
DNARの範囲	心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管など）を試みない指示。**心停止時だけ有効**	日本集中治療医学会「DNAR指示のあり方についての勧告」（2017）
通常の医療は控えない	酸素・挿管・人工呼吸・昇圧薬・抗菌薬・輸液・栄養・ICU入室を、DNARを理由に自動的に差し控えない。「心停止」を「急変時」とすり替えない	同上
partial DNAR	胸骨圧迫だけ行って挿管しない、といった部分的な蘇生はしない（不完全な蘇生では救命できない）	同上
スローコード	意図して不完全に行う蘇生は、患者への危害・尊厳の侵害・家族への欺瞞にあたる	AHA 2025 蘇生ガイドライン 倫理編（PMID 41122890）。DNRの院内方針の起点は1976年のNEJM（PMID 934225）
原疾患限定の根拠は？	学会の文書で「原疾患による心停止だけに適用」と定めたものは見当たらない。委員会報告は、別の原因、特に医療行為の合併症で心停止したときの対応を事前に話し合うよう求めるにとどまる	日本集中治療医学会 委員会報告（2016）。一部の病院指針は「予期しない原因の心停止は原則蘇生」としているが、「予期しない」の定義はない

§3 原疾患限定論への2つの反論

心停止の原因はその場ではわからず、原因がわからなくても無益なことに変わりはありません。ただしフレイルのエビデンスは「蘇生するな」とまでは言っていません。

反論① 原因はその場ではわからない

酸素7 Lの肺炎患者が急に止まったら、それは肺炎のせいなのか。線は引けません。発見するのはたいてい看護師で、その場で原因を判断させるのは無理があります。「発見したら原因にかかわらず蘇生する」のなら、それはDNARではなくフルコードです。

反論② 無益は原因を問わない

- 医療者がDNARを持ち出す根拠の多くはCPRの無益性。ここでいう「無益」は、**その人にとって**CPRに利益がないという意味で、資源やコストの話ではない。
- 本人が自分の価値観で蘇生を拒否するのは、別の正当な根拠になる（AHAは無益性と本人の拒否を並べて挙げている）[AHA 2025]。
- 無益と見込まれない患者に、医療者のほうからDNARを持ち出す理由はない（ACPとして情報を伝えるのはよい）。
- 年齢で切るのは雑で、見るべきはフレイル。

表2｜フレイルとCPR後の転帰

研究	デザイン	結果
Mowbray, Resuscitation 2021（PMID 34166743）	系統的レビュー・メタ解析	フレイルは心停止後の死亡と関連
Hamlyn, Resusc Plus 2022（PMID 35812717）	系統的レビュー・メタ解析（7研究1,704例）	CPR後死亡のOR 3.56。死亡率はフレイル90.2%、非フレイル71.6%
Ibitoye, Age Ageing 2021（PMID 32500916）	60歳超の院内心停止90例	CFS>4では生存退院0例、非フレイルは26%。年齢・併存症・リズムと独立（OR 2.789）
Yamamoto, Ann Emerg Med 2023（PMID 36964008）	日本の前向き多施設研究（院外心停止）	発症前のCFSが高いほど30日後の神経学的転帰が悪い

！エビデンスの限界

- CFSの閾値は研究ごとに違う（>4、≧5）。一律の線は引けない。
- 90例の後ろ向き研究で「無益」と断定するのは言い過ぎ。Hamlynらも、臨床判断に組み込むには検証と、生き延びた人のQOLの評価が要るとしている。
- 委員会報告は、後期高齢やADLの低さはそれだけで終末期とはいえず、それを理由にCPRを差し控えることが合法とはいえないとし、適応がずるずる広がる「滑りやすい坂」を警戒している [JSICM委員会報告2016]。

フレイルは「蘇生がうまくいくか」（医学の問い）は予測できるが、「この人にとって蘇生が最善か」（価値の問い）には答えない。

§4 土俵を一段上げる — AHA 2025と4学会合同ガイドライン

医学の問いと価値の問いを並べて量る。AHA 2025も4学会合同ガイドライン2026も、単一の指標ではなくプロセスで決める構造をとっています。

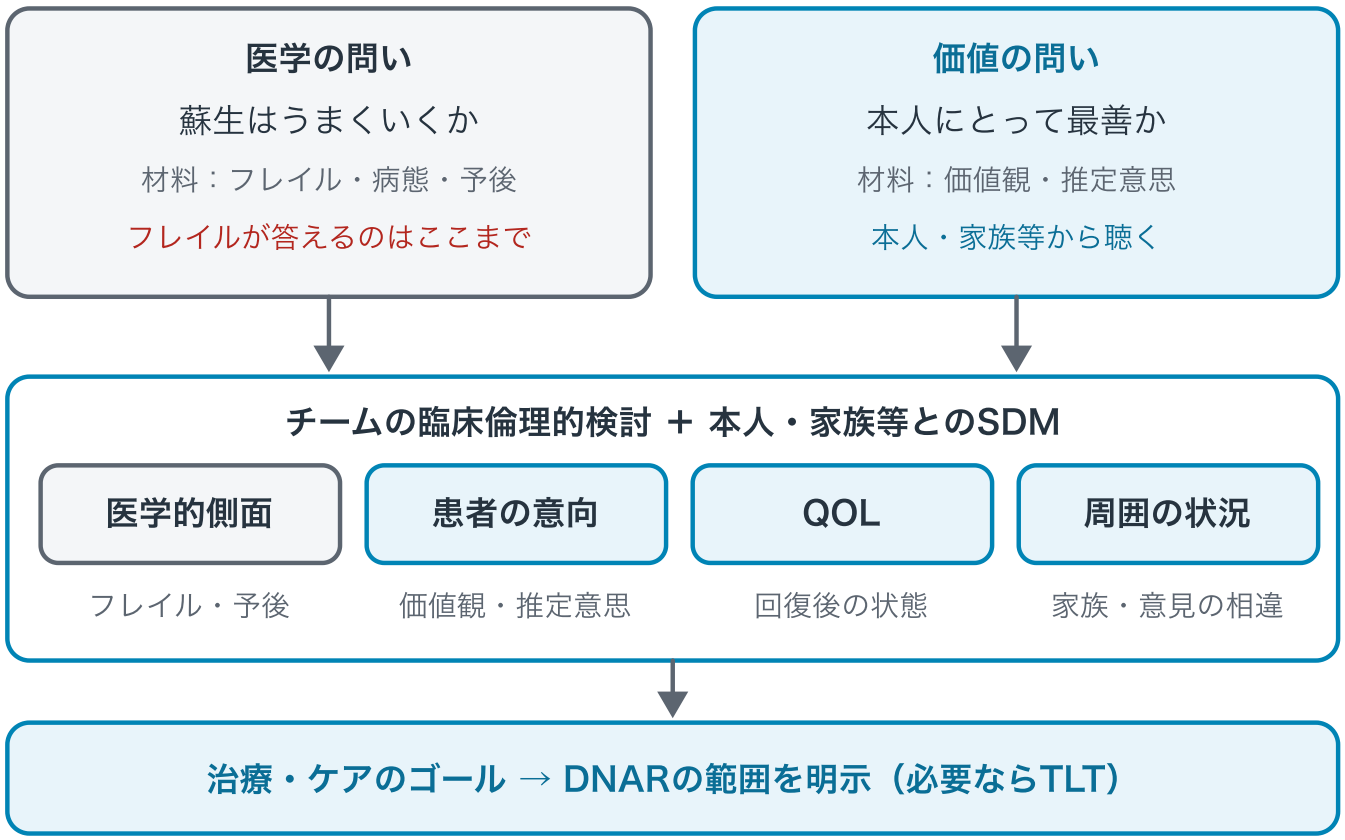


図1｜医学の問いと価値の問いを並べて量る。フレイルからの予後の見積もりは4つの側面のうち「医学的側面」の1つにすぎない。結論はゴールから出し、DNARはその範囲を明示した指示にする（4学会合同ガイドライン2026の構造をもとに作図）。

AHA 2025 倫理編

- 自律尊重・善行・無危害・正義の4原則を、どれも優先しない均衡の枠組みとして採る [AHA 2025]。
- 利益がないという判断には、価値観を含む主観が入りうる。重い神経障害を抱えて生きることを受け入れる人もいれば、受け入れない人もいる。
- 年齢を、生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしない。価値観を引き出す方法としてSDMを置く。

4学会合同ガイドライン（2026年9月確定版）

- **「終末期」を定義しない。**起点は「治療・ケアのゴール」で、一律の結論ではなく、最善のゴールを見出す「プロセス」を示す [4学会GL2026]。
- 判断の2本柱は、(1) 医療・ケアチームの臨床倫理的検討（医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況の4つ）と、(2) 患者・家族等とのSDM。フレイルからの予後の見積もりは、4つのうち「医学的側面」の1つにすぎない。
- 延命できるかどうかで線を引かない。旧ガイドラインでは生命が保てる限り終末期にあたらず、望まない治療が続いてしまった。Q&Aは、終了・差し控えの対象を従来の「終末期」に限らないとしている。
- 終末期でなくても、患者には生命維持治療を続けるか、終了・差し控えるかを選ぶ権利がある。
- 旧ガイドラインの例示（終末期4パターン、「近いうちに死亡」＝2〜3日）が線として読まれ、その外側で考えが止まった、と作成側が説明文で認めている。「DNARは原疾患の心停止に限る」という読み方も、同じ構造の誤り。
- Q&Aは、入院時に一律に設定する便宜的なDNARを否定し、**DNARは適用範囲が明確であることが不可欠**とする。

- 緩和ケア別編は、ACPの結論だけでなく、誰と・どんな状況で・どんな話し合いを経てその結論に至ったかを理解する重要性を強調する。問いかけの例は、できなくなったら生きていくのが考えられないこと、延命のためにどの程度のつらい治療まで受けたいか、の2つ。

§5 入院時の「DNARとらなきゃ」をやめる — いつ・何を聞き、何を記録するか

範囲の明確なDNARは必要ですが、それを入院の入口で一律に作る必要はありません。**入口では本人の推定意思を聴き、経過の中で蘇生方針を合意する。DNARとするなら範囲を明示する。**この章は、高齢者の緊急入院の入口で行われる一律の確認をやめる提案を、引用された一次資料で確かめて整理したものです。



入院の入口で最初に聞くのは、蘇生の可否ではなく「ご本人は何か話しておられましたか」。

55.9%
日本の医療・介護関連肺炎（596例、平均81.5歳）でDNARの意向確認が行われた割合

約94%
確認された333例のうち同意した割合（313例）。確認の時期は抄録からはわからない

1分
入院時のコードステータスの話し合いの長さ（中央値・録音研究）

Imamura, J Infect Chemother 2022 [PMID 35414437]／Anderson, J Gen Intern Med 2011 [PMID 21104036]

- 海外の流れは逆で、入院早期に治療目標を含む蘇生計画を記録する方向にある。南オーストラリア州はDNR指示を、治療目標を含む標準化された蘇生計画の書式に置き換え、記録は増えた。ただし70歳以上の内科入院患者のCPR・人工呼吸・ICU入室は減らなかった [Dignam, Aust Health Rev 2022・PMID 35508418]。
- **書式を変えるだけでは実践は変わらない。**問うべきは「入口で記録するか」ではなく「入口で何を記録するか」。

なぜ入口で確認したくなるのか — 人ではなく構造



指示がなければ全例フルコード。その重さを夜の当直医が一人で背負う構造が、入口の一律確認を生む。

- 指示がなければ全例フルコードになる、という既定値がある。夜間の急変では、その重さを当直医が一人で背負う。入口の一律確認は、個人の保身というより**この構造への防衛反応**と見るのが正確。
- 看護師には、望まれていたとは思えない蘇生の記憶がある。当直医は、手がかりのないまま夜中に重い判断を迫られることを恐れる。家族も、何も決まっていないことに不安を感じる。どれも軽んじない。
- だから直すのは人ではなく構造。記録の形（DNARの有無 → 話し合いの進捗）と、悪化が始まったときに誰がどう支えて家族と話すか、の2つ。

4つの違和感をエビデンスで確かめる

表3｜入口の一律確認への4つの違和感と、一次資料による検証

違和感	一次資料	結論
① 入院時点で無益性は見積もれない	心停止前の情報で転帰を予測するGO-FARスコアは、識別能は許容範囲（統合C統計量0.78）だが、良好な転帰を系統的に低く見積もる [PMID 36503620]。65歳以上の院内CPR後の生存退院は18.3% [PMID 19571280]。院内死亡はCFSとともに段階的に上がり、CFS 6以上で84% [PMID 34981346]	**支持**。集団の見通しは厳しいが、一人の確率は言い当てられず、誤差は悲観側に寄る。最重症の層でも16%は生存退院している
② 悪くなってからでも話し合える	一般病棟の心停止64例のうち84%で、8時間以内に悪化の徴候か新しい訴えが記録されていた [PMID 2245680]。一方、蘇生を望まないと表明した患者のうちDNR指示が出ていたのは52% [PMID 8678391]	**半分支持**。多くは前兆があるが、その数時間（しばしば夜間）を支える体制が要る。待つなら、**声だけは早く聴く**
③ 確認は誰のためか	入院24時間以内のDNR指示は年齢で2%から17%まで幅があり、患者の要因を調整しても病院の特性で変わり、郡ごとの標準化率に10倍の差があった [PMID 16087817]。75歳以上では予後にかかわらず早く書かれていた [PMID 8678391]	**輪郭が明確に**。DNAR指示は予後より、年齢と施設の文化で動く。過剰（年齢で早く書く）と過少（望む人の半数に出ない）が同時に起きている
④ 関係の入口として重すぎる	入院24時間以内の話し合いの有無で、患者・代理人の満足度に差はなかった（約1.2万人） [PMID 20713421]。ただし録音研究では、話し合いは80件中19件、中央値1分、予後に触れたのは1件、推奨を述べた医師はいなかった [PMID 21104036]	**満足度では支持されない**。ただし入口の確認が利益をもたらす根拠もない。実際の形は、1分の儀礼か、中立を装った誘導に傾きやすい。問題は時期より形

- 自律を重んじる病院では、研修医が自律を「選択肢のメニューを示すこと」と捉えて推奨をためらい、蘇生の場面を生々しく描いて選択を思いとどまらせる話法に頼っていた [PMID 30460704]。
- 代理で決める家族の少なくとも3分の1が、ストレス・罪悪感・決定への疑念といった負担を抱え、本人の意向を知っていることが負担を減らす要因として繰り返し挙がった [PMID 21357911]。

代案 A〜E

✕ 入口でやめること

- 「蘇生はしませんよね」と確かめる
- 蘇生の場面を生々しく描いて思いとどまらせる
- 選択肢を並べて家族に決めさせる
- 「DNARの有無」だけを記録する

○ 代わりにすること

- 本人が大事にしてきたこと、望まないと話していたことを「何か伺っていますか」と聞く
- 「特に聞いていない」も正当な答えとして受けとめる
- 家族を「本人の声を運ぶ人」と位置づける
- 共有された認識の進捗を記録する

表4｜代案 A〜E

代案	すること	ポイント
A 入口では推定意思だけを確認	生命の脅威が大きくなければ、本人が大事にしてきたこと、してほしくないと話していたことを「何か伺っていますか」と聞く	「特に聞いていない」も埋めるべき欠落ではなく、**正当な答え**。本人がその場にいれば、認知症があっても本人にも聞く。家族は「決める人」ではなく**「本人の声を運ぶ人」**
B 入口で蘇生を話すのは、判断が迫るときだけ	挿管・ICU入室など、数時間以内に治療を強めるかの判断が迫るときに限る	そのときも蘇生の可否だけを切り出さず、治療目標の話し合いとして行う
C 経過の中で、必要なときに	悪化の兆し、初期治療への反応が乏しい、家族から問いかけがあった、のどれかで話す	入院後の経過を見るほど判断が確かになる、という見方はまだ仮説
D 誘導しない。推奨するなら理由とともに	「しませんよね」と聞かない。蘇生の場面をことさら生々しく描かない	選択肢を並べて委ねるのも中立ではない。推奨があれば、本人の語りに根ざした理由とともに率直に伝える。**年齢だけは理由にならない**
E 記録を「進捗」に変える	「DNARの有無」ではなく「共有された認識の進捗」（回復の見込み・向かうゴール・本人の推定意思）を書く	当直医の問いは「なぜDNARでないのか」から「どこまで話が進んでいるか」に置き換わる。DNARが未記載なのは怠慢ではなく、プロセスの途中

看護師の不安には「暫定フルコード」で答える

✓ 書き方

コードステータスの書かれていない指示簿には、看護師から不安の声が出る。説教をせず、「現時点では回復の見込みがあるので、心停止時は暫定的にフルコードとする。経過が厳しくなれば、その時点で範囲を話し合って書く」と伝え、**「暫定フルコード（状況により随時検討）」**と書く。

- 「暫定」は決定の先送りではない。推定意思の確認がどこまで進み、次にいつ話し合うかを一緒に書く（§10 文例0）。
- 経過で話し合い、本人の価値観と治療目標から蘇生方針を合意する。DNARとする場合は「原因を問わず」と適用範囲を明示する（§6）。

日本の枠組みとの関係

- **厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（2018改訂）**：本人の意思が確認できなければ、家族等が推定する意思を尊重する。推定できなければ、本人にとっての最善を家族等と医療・ケアチームで話し合う。状態の変化に応じて繰り返し、その都度文書にする。
- **日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）**：DNARは心停止時のみ有効。DNARと終末期医療は同じではなく、別々に合意を形成する。DNARの合意形成は終末期医療のガイドラインに沿って行い、繰り返し妥当性を評価する。
- **4学会合同ガイドライン Q&A（2026）**：入院時に一律に設定する便宜的なDNARを否定する [4学会GL2026]。

入口で「蘇生はしませんよね」と聞く慣行は、チームによる状況の判断、推定意思の確認、十分な話し合い、繰り返し、のいくつもの段階を飛ばしている。

時間軸で整理する — 入口では価値観を聴き、経過の中で範囲を決める

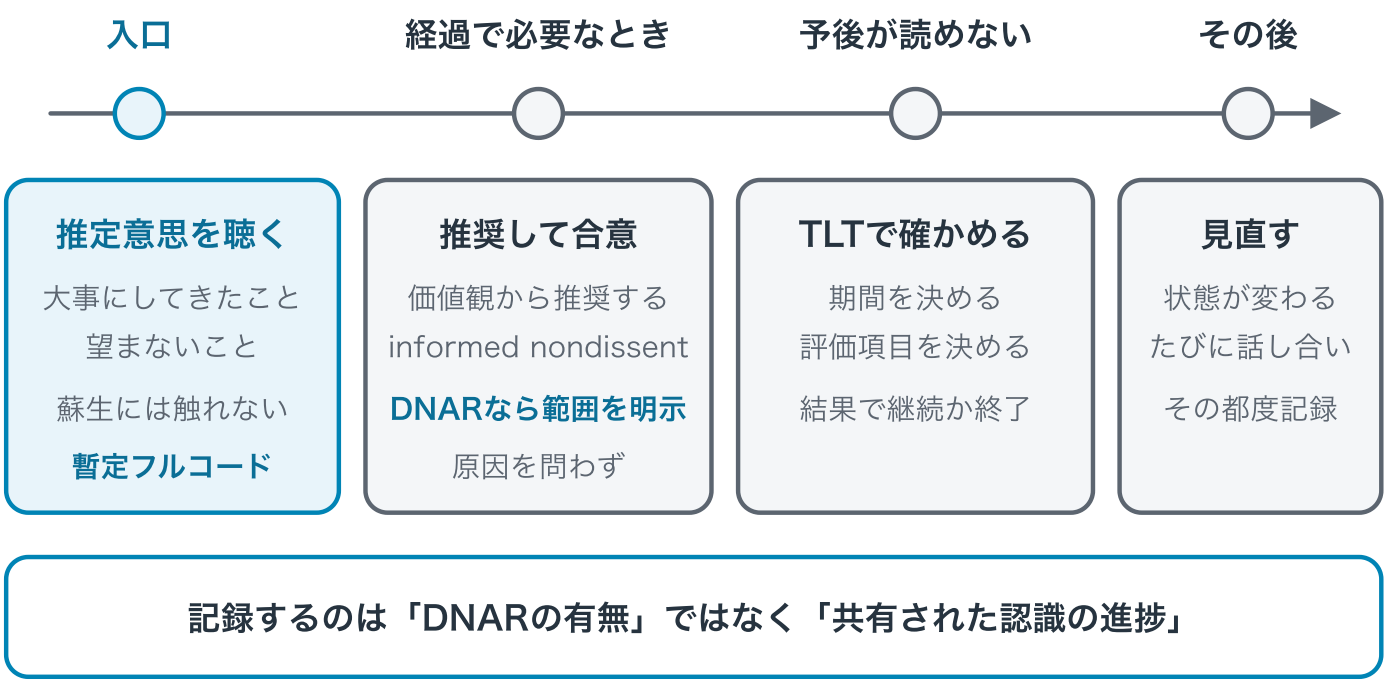


図2｜入口では価値観を聴き、経過の中で範囲を決める。入院時に一律にDNARを作らず、推定意思だけを確かめて暫定フルコードと書く。蘇生について話し合うのは、判断が迫ったときか経過の中で必要になったとき。そのときは本人の価値観と治療目標から蘇生方針を合意し、DNARとするなら範囲を明示する。予後が読めなければTLTで確かめる（厚労省プロセスガイドライン・日本集中治療医学会2017年勧告・4学会合同ガイドライン2026の構造をもとに作図）。

- 入口（入院時）：推定意思と大事にしてきたことを聴く。蘇生には触れない。暫定フルコードと書き、話し合いの進捗を記録する（§10 文例0）。
- 数時間以内に判断が迫るとき：蘇生を含め、治療目標の話し合いとして話す（§4のSDM）。
- 経過で必要になったとき：聴いた価値観をもとに医療者が推奨し、informed nondissent で合意する。DNARとする場合は「原因を問わず」と範囲を明示する（§6）。
- 予後が読めないとき：期間と評価項目を決めて、TLTで試す（§7）。

§6 現場での動き方

価値判断はベッドサイドではなく事前の話し合いで済ませ、その結果を範囲の明確な指示にします。看護師は指示に従い、医師は推奨と決定を引き受けます。



発見者の看護師が迷わないかどうかは、上流で医師が書いた指示の範囲で決まる。

看護師（発見者）

- その場で本人の価値観に立ち返る必要はない。価値判断は事前の話し合いの場で済ませておき、その結果を「原因を問わず、心停止時はCPRを行わない」という範囲の明確な指示にしておけば、看護師は指示に従うだけでよい。これがDNARを「オーダー」にする意味である。
- 指示の範囲が曖昧で迷ったら、蘇生を始めながら確認する（AHAの既定動作） [AHA 2025]。その責任は指示を曖昧にした側にあり、直すべきは上流。

医師の提案は informed nondissent



価値観を聴いたうえで、医療者が推奨を示す。決断の重荷を家族だけに背負わせない。

informed consent

「蘇生しない方針を勧めます。よろしいですか？」と同意を取る。

informed nondissent

伺った価値観と病状を踏まえて医療者が方針を示し、**反対があれば言ってもらい、なければその方針で進める** [AHA 2025]。

- 決断の重荷を家族に背負わせず、医療者が一方的に決めるのでもない。明確な拒否権を残したまま、専門家が推奨と決定を引き受ける構造になる。
- 日本ではまだ一般的ではない。家族が決定を医療者に委ねたいかどうかと、どの決定を委ねるのかを具体的に確認してから使う。
- 「挿管しますか？」「昇圧薬を使いますか？」と選択肢を選ばせない。価値観を十分に引き出したうえで、最善と考える案を提案する。

訴訟の懸念

4学会合同ガイドラインの説明文によれば、適切なプロセスを踏んだ終了・差し控えが刑事裁判で違法とされることはないと考えられ、2007年以降、刑事事件になった例は確認されていない [4学会GL2026]。民事は別。どちらにしても、話し合いの過程を記録することが最大の防御になる。

窒息と医原性の心停止

- 気道が詰まって苦しんでいる段階での異物除去や吸引はCPRではないので、DNARとは無関係に行う。
- 窒息で心停止した後にCPRをするかどうかは、「窒息だから」でなく、事前に合意した範囲で決まる。「原因を問わず」の指示なら、窒息による心停止も範囲に入る。
- **例外として事前に検討しておくのは、処置に伴う可逆的な医原性心停止。**原因がわかり、可逆性が高く、処置に同意した時点で合併症からの回復は本人のゴールに含まれている。日本集中治療医学会の調査では、DNARのある80歳心不全患者が内視鏡中の喉頭痙攣で心停止した場合、83.4%の医師が「CPRをする」と答えた。
- ただし医原性なら自動的に蘇生するのではない。処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを、目的・期待される状態・価値観を踏まえて事前に決めておく。

DNARオーダーの書き方の一案 実装の一案

！ガイドラインのルールではない

以下は、原因をその場で推定できない病棟で「適用範囲を明確にせよ」というガイドラインの要求をどう実装するか、の一案です。4学会合同ガイドラインが定めたルールではありません。

1. 心停止時は原因を問わずCPRを行わない（看護師に原因を判断させないため）
2. 窒息による心停止も含む（DNARを考える患者では十分に起こりうるため）
3. 処置に伴う医原性心停止は、処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを事前に決める（処置に同意した本人のゴールに沿うため）
4. 蘇生後、本人の望む状態に戻れないとわかれば速やかに終了する（一度始めたらやめられない、という縛りを外すため）

- 記録は4学会合同ガイドラインが求める項目にそろえる：患者の意思、推定意思の根拠、考慮する時期とその根拠、最善の選択肢の検討内容、検討に加わったメンバー（§10）。範囲と根拠が書かれていなければ、夜勤の看護師には伝わらない。
- 学会の調査では、DNAR指示自体の記録は9割だが、協議の過程の記録は7割にとどまった。
- 制度：令和6年度から、意思決定支援の指針を作ることが入院基本料の要件になった（ICUだけでなく全病棟）。

§7 TLT — 時間を味方につける

予後が読めないときは、期間と評価項目を決めて試す。ACPとTLTを両輪にすれば、「フルコードか、何もしないか」の二択から抜け出せます。



TLTは「何日たったら、何を見て、どう決めるか」を最初に決めておく試み。

- 4学会合同ガイドラインに明記された **time-limited trial（期限付きの特定の治療の試行）** [4学会GL2026]。対象は心停止時のCPRそのものより、ROSC後の人工呼吸などの生命維持治療。
- 意見が割れている、または予後が不明確なときに、関係者が合意して期間を決め、本人のゴールに向かって改善するかを確かめる。ガイドラインの例は「7日間の人工呼吸管理で、臓器機能の回復と合併症を評価する」。改善すれば一定期間ごとに増強・継続・減弱・終了を話し合い、悪ければ終了を検討する。
- 説明文は、「一度始めたらやめられないなら最初から始めない」という誤った判断が救命可能な患者の初期治療をためらわせる、と改訂の動機に挙げている。

× TLTは免罪符ではない

「迷ったらとりあえず始める」ためのものではない。侵襲的な治療が長引けば「死のプロセスの質」を損なう。何を目標に試すか、いつ何で再評価するか、その結果が価値観とどう結びつくかを事前に決めておかなければ、「決めきれないから続ける」延命の先延ばしになる（Q&A） [4学会GL2026]。

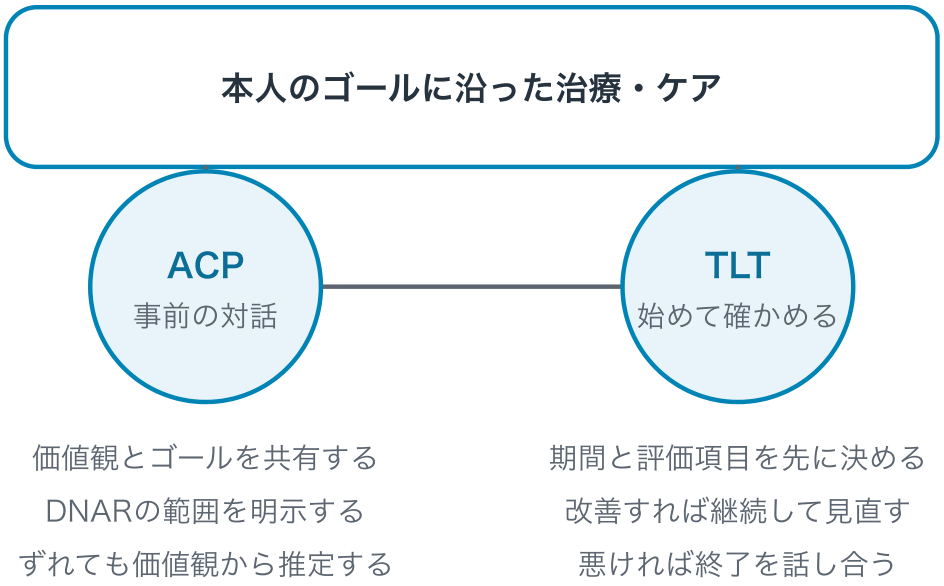


図3｜ACPとTLTは車の両輪。ACPで価値観とゴールを先に共有し、予後が読めないときはTLTで期間と評価項目を決めて試す。どちらが欠けても、ベッドサイドで「原因は何か」を問う運用に戻ってしまう。

- ガイドラインは、ACPの内容が実際の臨床状況と食い違っていても、適用できると判断されれば尊重し、状況が予想と違っても本人の価値観をもとに意思を推定してよいとする。**予期した心停止か、予期しない心停止かで線を引く必要はそもそもない。**ベッドサイドの原因論は、上流で要らなくなるように設計する。
- ガイドラインの対象はICUに限らず、急性期病院で治療の意思決定を行うすべての患者で、一般病棟の症例も含まれる。

§8 最終版の3原則

無益の見込みは材料、範囲は明示、決め方はプロセス。この3つにまとめます。

3原則

1 無益の見込みは「材料」であって「結論」ではない
フレイルなどからCPRが無益と予想されることは、医療者がDNARを考える重要な医学的材料である。

2 DNARは「原因を問わず心停止時にはCPRを行わない」と範囲を明示して運用する
処置に伴う可逆的な医原性心停止など、本人のゴールから蘇生が妥当になりうる状況は、例外として事前に検討し、必要ならDNARを一時的に変更・解除しておく。

3 単一の指標で線を引かない
年齢・フレイル・無益性で線を引かず、その人にとっての治療・ケアのゴールを、チームの臨床倫理的検討と本人・家族等とのSDMで探り、必要ならTLTで確かめながら、繰り返し見直す。

2の「原因を問わず」は4学会合同ガイドラインの一律のルールではありません。ガイドラインが求めているのは「適用範囲を明確にせよ」までで、そこから先は実装の提案です。病院文化の変更には時間がかかります。他職種の味方を探し、ガイドラインを一緒に読み、倫理委員会や法律の専門家と議論するところから始めます。

§9 用語の定義と使い方

同じ言葉を同じ意味で使うことが、範囲の明確な指示の前提になります。避ける言い方も並べました。

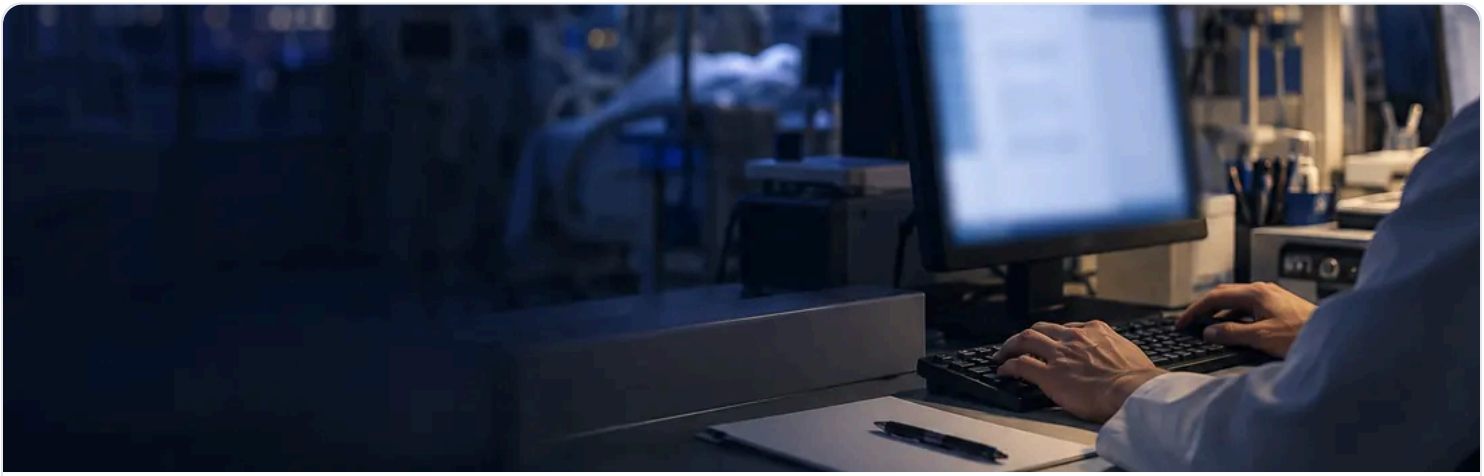
表5｜用語の定義と使い方

用語	定義・使い方	避ける言い方
DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）	心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬）を試みない指示。**有効なのは心停止時だけ**。「蘇生を試みない」であって「治療をしない」ではない	「急変時DNR」「DNARなので挿管しない」
DNR	旧来の呼び方。蘇生が成功する前提に聞こえるため、DNARに置き換わった	—
コードステータス／フルコード	心停止時の蘇生方針の区分。フルコード＝心停止時にCPRを行う	—
partial DNAR	胸骨圧迫だけ行って挿管しない、といった部分的な蘇生。**行わない**（救命につながらない）	「心マだけ」「挿管なしCPR」
スローコード	形だけの、意図して不完全に行う蘇生。患者への危害で、家族への欺瞞にあたる。**行わない**	「形だけ」「ゆっくりコール」
生命維持治療の差し控え／終了	開始しないこと（withholding）と、行っている治療をやめること（withdrawal）。4学会合同ガイドラインでは「中止」ではなく「終了」と書く。倫理的には同等に扱う	「治療中止」
終末期	4学会合同ガイドライン（2026）はあえて定義しない。終了・差し控えは「終末期」に限らず、治療・ケアのゴールから判断する	「終末期なので」を判断の根拠にする
治療・ケアのゴール（Goals of care）	本人の価値観に照らして、治療で何を目指すか（延命・機能回復・苦痛の緩和・自宅に帰る など）	—
無益（futility）	**その人にとって**利益が見込めないこと。医療資源やコストの話ではない	「もったいない」「意味がない」
ACP（人生会議）	本人の価値観を家族・医療者と共有し続けるプロセス。書類を作ることではない	「ACPを取る」
事前指示／リビングウィル	ACPの結果を書面にしたもの。それだけでは効かないことが多い	—
SDM（共同意思決定）	価値観を聞く段階は本人・家族が主導し、選択肢を勧める段階は医療者が主導する、という役割分担で一緒に決める	選択肢を並べて選ばせる
推定意思	本人が意思を示せないとき、家族等の話から推定する本人の意思。「家族の希望」とは区別して記録する。**入院時の入口で確認するのはこれだけ**（本人が大事にしてきたこと・望まないと話していたことを「何か伺っていますか」と聞く）。「特に聞いていない」もそのまま記録する正当な答え	「家族がDNARを希望」「家族の意向でDNAR」

用語	定義・使い方	避ける言い方
暫定フルコード	推定意思の確認や話し合いが途中で、回復の見込みがあるときに、心停止時はCPRを行うと仮に置く書き方。「暫定フルコード（状況により随時検討）」と書き、話し合いの進捗と次に話し合う契機を添える。決定の先送りではない	「DNAR未取得」「DNAR取れず」
家族等	4学会合同ガイドラインの用語。法的な親族に限らず、本人が信頼する人を含む	—
informed assent	価値観と病状を踏まえて医療者が「○○はしません」と方針を伝え、質問を受ける。無益性が明らかで、価値観もはっきりしているときに使う	—
informed nondissent	医療者が推奨と方針を示し、反対があれば言ってもらい、なければその方針で進める。拒否権を明示して残す（AHA 2025）	—
informed consent	選択肢と推奨を説明し、同意を得る	—
TLT（time-limited trial）	期間と評価項目を決めて、特定の治療を試行する。結果で継続・増強・減弱・終了を決める	「とりあえず様子を見る」

§10 カルテ記載の文例

4学会合同ガイドラインが記録を求める項目と、DNARの適用範囲を書きます。[ ] は症例ごとに書き換える箇所です。



範囲と根拠が書かれていなければ、夜勤の看護師には伝わらない。

記録を求められる項目：患者の意思、推定意思の根拠、考慮する時期とその根拠、最善の選択肢の検討内容、検討に加わったメンバー [4学会GL2026]。文例1の「原因を問わず」「窒息を含む」「処置に伴う心停止は事前に決める」は、ガイドラインのルールではなく実装の一案です（§6）。

文例0 入院時の記録

文例0：入院時の記録（推定意思の確認と、話し合いの進捗）

【入院時：推定意思の確認と話し合いの進捗】
・コードステータス：暫定フルコード（状況により随時検討）
　理由：**[現時点では回復の見込みがある／初期治療への反応を見てから話し合う]**
・本人の推定意思：**[家族等の氏名・続柄]** に、本人が大事にしてきたこと・望まないと話していたことを尋ねた。
　回答：「**[家族等が語った本人の言葉。特に聞いていない場合は、そのとおり記載]**」
　本人への問いかけ：**[本人に尋ねた（反応）／意識障害のため困難]**
・共有された認識（どこまで話が進んだか）
　回復の見込み：**[説明した内容と、家族等の受けとめ]**
　向かうゴール：**[まず肺炎を治療し、元の生活に戻ることを目指す／まだ話していない]**
　蘇生について：**[入口では話していない（判断が迫っていないため）／治療目標の話し合いとして話した（内容）]**
・次に話し合う契機：**[悪化の兆し／初期治療への反応が乏しいとき／家族等からの問いかけ／○月○日]**
・記載者：**[氏名・職種]**

文例1 DNAR指示の範囲

文例1：DNAR指示（範囲を明示する）

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）
・適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
・例外：**[内視鏡／CV挿入など]** 処置に伴う心停止の扱いは、処置前に本人・家族等と確認する。
（今回の取り決め：**[処置中はDNARを一時解除し蘇生を行う／解除しない]**。蘇生後に本人の望む状態に戻れないと判断した場合は、生命維持治療の終了を検討する）
・DNARを理由に控えない治療：酸素投与、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]** などは適応に応じて継続する。
・心停止前の治療の方針（DNARとは別に決定）：呼吸不全時の気管挿管 **[行う／行わない／TLTとして行う]**、透析 **[…]**、ICU入室 **[…]**
・再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

文例2 面談記録

文例2：意思決定の過程（面談記録）

【面談】**［日時］［場所］**
参加者：本人 **［参加／不参加（理由：鎮静中など）］**、家族等 **［氏名・続柄］**、医師 **［氏名］**、看護師 **［氏名］**、**［MSW・薬剤師など］**

1. 病状の説明
［病名・経過］を説明した。見通しは **［数日〜数週／数週〜数か月］**の単位で伝えた。
家族等の理解：「**［家族の言葉］**」

2. 本人の価値観・意向
［本人の言葉／家族等が語った本人の言葉］：「**［楽しみ・生きがい・こうなったら生きていたくない状態など、できるだけ逐語で］**」
推定意思の根拠：**［以前の会話・ACP・書面・普段の生活ぶり］**
→ 治療・ケアのゴール：**［苦痛を最小限にして家族と過ごす／自宅に帰れる可能性があれば治療を続ける など］**

3. 医療・ケアチームの推奨と合意
上記のゴールに照らして、心停止時の心肺蘇生は **［利益がなく苦痛を増やす可能性が高い］**と判断し、行わないことを推奨した。
提案の形：**［informed assent／informed nondissent／推奨し意見を求めた］**。家族等が決定を医療者に委ねたいことを **［確認した］**。
家族等の反応：**［異議なし／同意／保留（理由）］**。質問：**［内容と回答］**

4. チームでの臨床倫理的検討
医学的側面：**［予後・フレイル（CFS ○）・治療の見込み］**
本人の意向：**［上記2］**
QOL：**［回復した場合に予想される状態］**
周囲の状況：**［家族の状況・意見の相違の有無］**

5. 決定事項と保留事項
決定：**［DNAR（文例1の範囲）／挿管は行わない／…］**
保留：**［透析は次回の面談で］**
再評価：**［○月○日、または状態が変化したとき］**

文例3 TLT

文例3：TLT（期限付きの治療の試行）

【TLT】
・目的（本人のゴールとの関係）：**［人工呼吸から離脱し、会話できる状態に戻ること］**
・試行する治療：**［気管挿管・人工呼吸／CRRT］**
・期間：**［7日間］**（再評価日：**［○月○日］**）
・評価項目：**［酸素化の指標・昇圧薬の量・意識レベル・新たな臓器障害］**
・改善した場合：**［継続して、○日後に再評価］**
・改善しない／悪化した場合：**［生命維持治療の終了を含め、ゴールに沿った方針を家族等と話し合う］**
・合意した参加者：**［氏名・続柄・職種］**

文例4 本人が蘇生を望まない場合

文例4：本人が自分の価値観で蘇生を望まない場合（終末期でなくても）

本人 **［意思決定能力あり：理解・認識・論理的思考・選択の表明を確認］**より、「**［本人の言葉］**」との意思表示あり。
病状と、蘇生した場合に予想される経過を説明したうえで、本人の価値観に基づく選択として、心停止時の心肺蘇生を行わない（DNAR、文例1の範囲）。
家族等 **［氏名］**と共有 **［済／未（予定）］**。

記録で避けること

- 「急変時DNR」「DNR取得」：範囲が曖昧で、急変時に治療全般を控える読み方を招く。
- 「DNAR未取得」：主治医の怠慢のように読める。話し合いがどこまで進んだか（文例0）を書けば、プロセスの途中だと伝わる。
- 「家族がDNARを希望」だけを書く：本人の価値観・推定意思の根拠・医療者の推奨を書かないと、何を合意したのかが残らない。
- チェック欄だけで済ませる：DNARの有無だけでは、合意の範囲と理由が夜勤の看護師に伝わらない。

一次資料と関連資料

- 日本集中治療医学会「DNAR指示のあり方についての勧告」（2017） https://www.jsicm.org/publication/kankoku_dnar.html
- 日本集中治療医学会 委員会報告（2016） https://www.jsicm.org/pdf/DNAR20161216_kangae_05.pdf
- 4学会合同ガイドライン（2026） 公表 https://www.jsicm.org/news/news260928.html／本編 main.pdf／説明文 explain.pdf／Q&A QA.pdf／緩和ケア別編 supplement.pdf
- Elmer J, et al. Part 3: Ethics: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2025;152(16_suppl_2):S323-S352. PMID 41122890
- Rabkin MT, et al. Orders not to resuscitate. N Engl J Med. 1976;295(7):364-6. PMID 934225
- Mowbray FI, et al. Prognostic association of frailty with post-arrest outcomes following cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2021;167:242-250. PMID 34166743
- Hamlyn J, et al. Outcomes in adults living with frailty receiving cardiopulmonary resuscitation: A systematic review and meta-analysis. Resusc Plus. 2022;11:100266. PMID 35812717
- Ibitoye SE, et al. Frailty status predicts futility of cardiopulmonary resuscitation in older adults. Age Ageing. 2021;50(1):147-152. PMID 32500916
- Yamamoto R, et al. Frailty and Neurologic Outcomes of Patients Resuscitated From Nontraumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Prospective Observational Study. Ann Emerg Med. 2023;82(1):84-93. PMID 36964008
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（2018改訂） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html
- Imamura Y, et al. Prospective multicenter survey for Nursing and Healthcare-associated Pneumonia in Japan. J Infect Chemother. 2022;28(8):1125-1130. PMID 35414437
- Dignam C, et al. The impact of standardised goals of care documentation on the use of cardiopulmonary resuscitation, mechanical ventilation, and intensive care unit admissions in older patients. Aust Health Rev. 2022;46(3):325-330. PMID 35508418
- Hakim RB, et al. Factors associated with do-not-resuscitate orders: patients' preferences, prognoses, and physicians' judgments. Ann Intern Med. 1996;125(4):284-93. PMID 8678391
- Zingmond DS, Wenger NS. Regional and institutional variation in the initiation of early do-not-resuscitate orders. Arch Intern Med. 2005;165(15):1705-12. PMID 16087817
- Ehlenbach WJ, et al. Epidemiologic study of in-hospital cardiopulmonary resuscitation in the elderly. N Engl J Med. 2009;361(1):22-31. PMID 19571280
- Hu FY, et al. Frailty and Survival After In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation. J Gen Intern Med. 2022;37(14):3554-3561. PMID 34981346
- Amacher SA, et al. Predicting neurological outcome in adult patients with cardiac arrest: systematic review and meta-analysis of prediction model performance. Crit Care. 2022;26(1):382. PMID 36503620

- Schein RM, et al. Clinical antecedents to in-hospital cardiopulmonary arrest. Chest. 1990;98(6):1388-92. PMID 2245680
- Anderson WG, et al. Code status discussions at hospital admission are not associated with patient and surrogate satisfaction with hospital care. Am J Hosp Palliat Care. 2011;28(2):102-8. PMID 20713421
- Anderson WG, et al. Code status discussions between attending hospitalist physicians and medical patients at hospital admission. J Gen Intern Med. 2011;26(4):359-66. PMID 21104036
- Dzeng E. Habermasian communication pathologies in do-not-resuscitate discussions at the end of life. Sociol Health Illn. 2019;41(2):325-342. PMID 30460704
- Wendler D, Rid A. Systematic review: the effect on surrogates of making treatment decisions for others. Ann Intern Med. 2011;154(5):336-46. PMID 21357911

このページは公開されている論考と上記の一次資料をもとに論点を整理した要約で、原文の転載ではありません。写真は生成画像で、実在の人物・施設ではありません。

関連資料：ICUの臨床倫理と終末期の意思決定／なぜACPはうまくいかないのか／このページの講義スライド